

08 - 08- Tuberculoses Pulmonaires Aigues - Pr. Bouchentouf

Bonjour chers étudiants, les cours d'aujourd'hui ce sont les tuberculoses pulmonaires aiguës. Comme introduction, ce sont des formes rares, mais surtout graves de la tuberculose. Elles comportent la pneumonie caséreuse, la bronchopneumonie, qu'on appelle également physicalopente, et la mylière tuberculose aiguë.

Elles ont comme point commun un débit brutal, une symptomatologie bruyante réalisant un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Ce sont des urgences médicales, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques, et le pronostic les sert en absence de traitement précoce. On va commencer par la mylière tuberculose.

Comme définition, c'est une dissémination de petites granulations tuberculeuses, classiquement de taille d'un grain de mille, localisées au seul poumon ou disséminées à tout l'organisme. Elles touchent l'enfant et l'adulte jeune. Sur le plan anatomique, on distingue plusieurs stades anatomiques, la phase exudative, la caséification, le remaniement folliculaire et les cicatrisations fibreuses.

Le stade prédominant, nous pouvons expliquer certaines formes cliniques, dont la forme sur aiguë, ce qui prédomine, c'est le stade exudatif, dont les formes froides, c'est essentiellement les formes folliculaires, et dont les mylières avec des cavités, elles sont secondaires à la caséification. Sur le plan pathogénique, il y a plusieurs mécanismes, le plus fréquent, c'est la dissémination par voie hématogène, mais on peut avoir d'autres voies de dissémination bronchogène, c'est une mylière localisée au niveau du poumon, une dissémination lymphatique et l'air rare, ce qu'on appelle surtout la mylière froide. La mylière froide, c'est l'absence de fièvre.

Vous avez un sujet contagieux qui part en voie aérienne, le sujet va être contaminé, on va avoir comme la physiopathologie de la primo-infection, on aura une primo-infection, donc 90% vont guérir et 10% vont donner une infection tuberculeuse latente. Si les conditions sont favorables, c'est à dire qu'on a une immunodépression, on aura une tuberculose maladie, qui peut être soit précoce avant deux ans, soit une réactivation tardive. Ensuite, au cours de cette infection tuberculeuse latente, on peut avoir une dissémination par voie bronchogène, qui va donner la tuberculose pulmonaire commune, ou une dissémination par voie lymphatique et hématogène, c'est-à-dire hématogène pour donner les mylières ou les autres localisations extra-pulmonaires.

Pour ce qui est du diagnostic positif de la mylière tuberculeuse, on va prendre en description la mylière généralisée, la forme pseudotuberculeuse d'impice, on aura la forme pseudotuberculeuse de l'endosie dans la primo-infection, on aura la forme pseudotuberculeuse d'impice dans la mylière tuberculeuse, c'est une mylière généralisée, on aura une phase de début généralement progressive, asthénie, anorexie, fièvre, séjour nocturne, emigrissement, et parfois un syndrome ménager, mais surtout la phase d'état, c'est-à-dire des septicémies, la fièvre, l'aterrissant, des céphalées, des diarrhées et des dyspnées variables, donc un tableau sous forme de septicémie. L'examen

physique, le pulmonaire est souvent mouillé, parfois on peut avoir des signes d'insuffisance respiratoire, des cyanoses, des excréments. Quand on atteint 2 mylières, on aura des râles crépitantes du flux, mais surtout chercher d'autres dissimulations, c'est-à-dire chercher d'atteindre d'autres visières, l'hépatopulmonaire qui est inconstant, et que la température et le poids ne sont pas dissociés, alors qu'ils sont des cercles de la typhoïde, un tableau comme de la typhoïde, mais il n'y a pas de dissociation de la température et du poids, et que la langue est propre et humide.

L'image rhétorique est très parlante. On recherche des micronodules de taille de 1,5 à 3 mm, qui sont bien limités, qui sont uniformément répartis dans les champs pulmonaires. Parfois, on peut avoir des granulations inégales, confluentes, unilatérales, associées à des images cavitaires ou reticulonodulaires.

Également, à côté des atteintes par enchymateuse pulmonaire, on va chercher d'autres lésions associées au niveau pleural, ganglionnaire, médiastinal, au niveau osseuse et péricardique. Vous voyez, c'est ça le graphé thoracique, vous avez des granulations diffuses de champs pulmonaires, qui sont bien limités, de petite taille, de 1,5 à 3 mm. C'est ça le tableau radiologique de Millières.

Devant ce tableau, dans notre contexte épidémiologique, il faut toujours penser à la Millière tuberculeuse. Vous avez cette radiographie thoracique, vous avez des petits nodules qui sont diffus avec des reticulations au niveau des deux champs pulmonaires. Voici un scanner thoracique, vous avez des granulations, des granulations, des petits nodules diffusent aux deux champs pulmonaires.

Vous voyez qu'il y a probablement une lésion pleurale, un pneumothorax probablement ici partielle, des lésions associées. Vous avez ce tableau radiologique. En premier lieu, on voit qu'à côté des Millières, ici à gauche, à côté des Millières, on a des petits nodules, des grands nodules, des opacités excavées.

Donc vous êtes atteint par un chimiste, c'est peut-être essentiellement des petits nodules, des Millières, des grains de mille. Puis après vous avez des nodules de grande taille, parfois des nodules qui sont trouvés, excavés. L'aspect typique, c'est les Millières, les micro-nodules, mais on peut avoir d'autres lésions associées.

Ces lésions peuvent être également par un chimiste, comme ici à droite, une caverne et des nodules au niveau du sommet, mais surtout autres lésions associées, d'autres organes, on a des adénopathies hilaires ici et des empochements pleuraux. Une pleurisy, ici à droite. Dans le cas du bulleux, pour le diagnostic, il faut un interrogatoire.

Il faut rechercher les facteurs favorisant notamment les milieux de dépression, un contaminateur éventuel, mais surtout l'absence de vaccination par le BCG. Également rechercher l'ensemble des primo-infections anti-tuberculeuses qui sont non traitées ou maltraitées. Surtout, il faut

recupérer les documents antérieurs, surtout la radio-infectariologie.

Il faut rappeler que l'intra-thermo-réaction est généralement positive. Chercher également les béquins. Les béquins, on va les rechercher dans les exploitations et dans les rues et dans le LCR, parce que c'est une biliaire avec une dissimulation à d'autres organes.

La biologie, elle peut être normale. On ne montre pas l'ococytose. Un syndrome inflammatoire, on pense à un syndrome insepissimique, on fait des hémocultures qui sont négatives.

Elles sont oubliées qu'on a des localisations. Il faut rechercher d'autres localisations extra-pulmonaires. On va rechercher les adenomatiques périphériques, atteindre des séreuses, pleurales, péricardiques, mais surtout ménager.

Il faut sortir des signes devant une biliaire tuberculose. Il faut sortir des signes des simulateurs. Surtout ménager.

On fait un fond d'œil à la recherche du tubercule corovidien de Bouchoute. Également, faire une pension lambert qui est systématique. Donc une biliaire, il faut rechercher des signes de diffusion d'autres organes.

Mais c'est une diffusion ménagée. Il ne faut faire que la pension lambert. Elle est systématique.

Autre examen à la recherche de dissimulation, un examen osteoarticulaire. L'examen orol à la recherche d'atteinte pharyngée. Également l'atteinte hématologique par la biopsie osteomodulaire, la myoculture à la recherche de PKA.

Également l'examen cytobactériologique des urines à la recherche de PKA dans les urines. Et la pension biopsie-hépatique. L'évolution est complication.

C'est une forme grave. L'évolution spontanée en absence de traitement, c'est la mort. L'évolution sous traitement qui doit être précoce et correcte.

Rapidement favorable. Amélioration clinique puis radiologique. Un traitement tardif risque de complication.

L'amortissement de 20 à 40%. D'où l'intérêt d'avoir une biliaire, un traitement qui doit être précocement instauré. Et les complications de la biliaire, peut-être de l'hémoptysie.

Peut-être de la dissimulation à distance en méningite ou méningoencéphalite. On peut avoir un pneumothorax ou un pneumothorax. Une atteinte de serreuse, une pericardite ou une peritonite.

Pour les femmes cliniques. On a des femmes avec une manifestation pleuropulmonaire très dominante. Soit on donne un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë qu'on appelle les femmes suffocantes.

Où on a des femmes avec atteinte pleurale. On a également des femmes extra-pulmonaires prédominantes. Atteinte méningite, une méningite tuberculeuse.

Atteinte laryngopharyngie isenberg, qu'on appelle isenberg. Des formes hématologiques. L'autre localisation.

Il y a des formes évolutives, c'est-à-dire la biliaire sub-aiguë, froide. Il n'y a pas de fièvre. Pour les lésions qui prédominent le stade anatomopathologique, c'est le stade folliculaire.

Pour le diagnostic différentiel. Tout d'abord, devant une biliaire fébrile. Il faut éliminer une infection non-tuberculeuse qui peut être bactérienne, virale, parasitaire, mycosique.

Il faut éliminer une cause immunoallergique, la myéloïde allergique extrinsèque. Également, sans oublier les pathologies malignes. L'hémopathie, la myélome carcinomateuse.

Également, une cause hémodynamique, l'œdème du poumon. Pour la myélome froide, il faut surtout éliminer les pneumopathies infiltrantes diffuses. La myélome carcinomateuse et surtout pneumoconiose ou le silicose.

Pour la deuxième tuberculose aiguë, la pneumonie caséeuse. Sur le plan anatomopathologique, il s'agit d'un alvéolite exsudatif, massif, homogène et systématisé. Il atteint un ou plusieurs territoires segmentaires ou lobaires.

L'alvéolite peut se casifier et se ramollir spontanément. Sur le plan clinique, le début est brutal. Avec un syndrome fébrile 39-40 degrés de frisson.

Un état général qui est très altéré. La phase d'état se dure 2 à 3 jours. On aura une dyspnée intense.

Une toux expectoration mycoïde. Parfois des hémoptisies. Une asthénie.

Une pâleur. Une cyanose. Un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë.

Un tableau également de pneumopathie. Mais qui différencie d'une pneumopathie bactérienne à pneumocoque. L'absence d'herpès labial.

Dans la pneumonie caséeuse, il n'y a pas d'herpès labial. Au cours de la phase d'état, malgré un traitement antibiotique non spécifique. La persistance de la fièvre et l'amalgamement.

Surtout l'examen physique trouve un syndrome de condensation. Donc, pensez à une pneumonie caséeuse devant une pneumonie bactérienne grave. Non améliorée par une antibiothérapie non spécifique.

L'imagerie thoracique. Vous avez cette opacité floue. Avec des zones moins denses.

Et parfois des cavités. Et vous voyez des ondules homo et contralatérales. Voyez cette image de pneumopathie.

Franche-Laubert avec des postés excavés. Le diagnostic positif. Quels sont les éléments d'orientation? Tout d'abord, c'est l'interrogatoire.

Surtout le terrain. Il faut chercher la notion d'immunodépression. Il faut chercher l'absence de vaccination de PCG.

Il faut chercher la notion de cas de tuberculose dans l'entourage. Et également, dans l'interrogatoire, il faut chercher la notion de pneumonie. Non améliorée par une antibiotérapie.

Il faut également chercher à l'examiner. Il y a d'autres localisations tuberculeuses. Les éléments d'orientation biologiques.

Avec le VAS, le syndrome inflammatoire. Et surtout l'intra-thermoérection tuberculaire. C'est positif.

Mais surtout la confirmation du diagnostic. C'est surtout bactériologique. La mise en évidence du bacille acido-alcool-résistant.

A l'examen de l'alcooloculture. A l'examen de l'alcooloculture par la collaboration de Zinn-Nilsson ou GeneXpert. Le diagnostic différentiel.

C'est surtout entre une pneumonie caselleuse. Et une pneumonie bactérienne. Le début d'une pneumonie caselleuse est progressif.

Même si on suit une tuberculose. Si on compare par la pneumonie bactérienne. Le début est progressif par rapport à la pneumonie bactérienne.

Lorsqu'on parle d'une tuberculose aiguë. Bien sûr on la compare avec la tuberculose autre au début. Mais lorsqu'on la compare avec une autre pneumonie bactérienne.

Le principal diagnostic. Le début de la pneumonie caselleuse est progressif. Alors que le début de la pneumonie bactérienne est brutal.

Et surtout on cherche l'herpès labial. La présence de l'herpès labial est présente dans la pneumonie bactérienne. Et absente dans la pneumonie caselleuse.

L'hyperleucocytose est franche dans la pneumonie bactérienne. Et elle est peu importante dans la pneumonie tuberculeuse. Et l'opacité radiologique.

Les deux ne sont pas systématisées. Mais surtout l'évolution sur le traitement non spécifique. On a une bonne évolution sur la pneumonie bactérienne.

Et une mauvaise évolution. Dans toute pneumonie non améliorée. Pas une antibiotique spécifique.

Il faut penser à la tuberculose. L'évolution. Sur le traitement et les précautions.

On a l'agression des signes cliniques. L'exclavation. On peut avoir l'exclavation et l'attraction du foyer pneumonique.

Et on peut avoir des séquelles. Qui sont sources de complications. On peut avoir des séquelles surinfectées.

De germes. Ou d'agents bactériens. Comme l'aspergillum.

Et l'évolution peut être défavorable. Surtout en absence d'un traitement précoce. Il faut insister sur la notion de traitement précoce.

Si on n'a pas un traitement précoce. La mort peut se revenir dans 3 à 4 semaines. Dans un tableau d'altération de temps général.

Et d'insuffisance respiratoire aiguë. La 3ème forme de la tuberculose pulmonaire aiguë. La tuberculose aiguë.

C'est la bronchopneumonie tuberculeuse. Sur le plan anatomique pathologique. C'est une atteinte de bacillère par la bronchogène.

De plusieurs lobules pulmonaires. Qui va évoluer vers la casification. Et le ramollissement.

Sur le plan clinique. Le début est brusque. Avec une fièvre sur une octave.

Des signes d'insuffisance respiratoire aiguë. La dyspnée. La cyanose.

De la toux. Et surtout l'altération importante de l'état général. L'examen physique.

On va trouver des râles renflants. Des râles cripitants-sucritants. Nous avons une atteinte dans la bronchoponie.

Une atteinte bronchique. Et pas en chimatose. On peut avoir des râles cripitants.

Et des râles renflants. On ne voit pas d'aspect des signes. Contrairement à la pneumonisation.

On va s'attendre à des condamnations. Mais surtout l'examen général. A la recherche d'autres localisations.

Tuberculeuses. Peut-être gonglionnaires. L'image rhétorique.

La bronchopneumonie tuberculeuse. La physique galopante. Les dents disséminées.

Plus ou moins denses. De taille variable. Parfois confluent.

Parfois excavées. Pour ce qui est du diagnostic positif. Toujours les éléments d'orientation.

La confirmation du diagnostic. Les éléments d'orientation. Le syndrome inflammatoire.

L'intradermoréaction tuberculeuse. La confirmation. Bactériologique.

Par les BK. Les BK qui sont positifs. A l'examen direct.

Souvent par examen des expectorations. Parfois tubage. Parfois par fibroscopie.

La confirmation bactériologique. Par la coloration de zinc-linsol. Ou par le gène expert.

Le diagnostic différentiel. Devant une bronchopneumopathie aiguë. En bronchopneumotuberculeuse.

Il faut éliminer les bronchopneumopathies. Non tuberculeuses. Bactériennes, virales, mycosiques.

Ou toxiques bactériennes. Les bacilles. Les virales.

Mycosiques. Les bronchopneumonules. Les toxiques.

Pour l'évolution. Il faut insister sur le traitement précoce. On peut avoir des régulations décliniques.

Et radiologiques. Mais ce sont des formes graves. On peut avoir des séquelles.

Soit des dilatations des branches. Soit des bulles. Soit de l'insuffisance respiratoire.

Et la pollution en absence de traitement précoce. C'est défavorable par de l'hémoptysie. De l'insuffisance respiratoire.

Et par la dissémination. Pour ce qui est du traitement. Le but c'est de guérir les malades.

Éviter les séquelles. Rompre le cycle de transmission. Et réduire la mortalité.

Pour ce qui est du traitement. Le traitement est surtout des antibacillaires. Un traitement qui doit être précoce.

Pour éviter les complications. Ou pour éviter la mort. Associer le traitement tuberculeux.

A un traitement adjuvant. Nous avons des sujets qui sont en insuffisance respiratoire. Donc l'oxygénothérapie.

Mais également la corticothérapie. En cas d'insuffisance respiratoire. Ou en cas de dissémination

méningée.

Le traitement doit être précoce. Et basé surtout sur les antibacillaires. A qui on peut ajouter de l'oxygénothérapie.

Et la corticothérapie comme traitement adjuvant. Pour ce qui est de la prévention. Surtout la vaccination par le PCG.

Faire une enquête de dépistage. Pour les sujets à risque. C'est-à-dire les ménings déprimés.

Le VIH. C'est la chimioprophylaxie. Et surtout l'amélioration des conditions de vie.

Un message très important. Que le tuberculose aiguë est une urgence. Il faut le traiter sans retard.

Et sans attendre les résultats. Dans le cas du tuberculose pulmonaire commun. Il faut attendre la confirmation.

Avant d'instaurer un traitement. Mais dans le cas du tuberculose aiguë. La mylière, la physigalopente.

Ou la pneumonie casée. Il faut le traiter sans retard. Et sans attendre les résultats.

Merci de votre attention.